# IMAGENOLOGÍA EN CIRUGÍA

DRA. DEBBIE WONG

**RX Abdominopélvica <u>normal</u>**

Estudio de partida en cirugía. Permite ver hígado, riñones y asas intestinales; el detalle depende de la definición y penetrancia de la técnica.



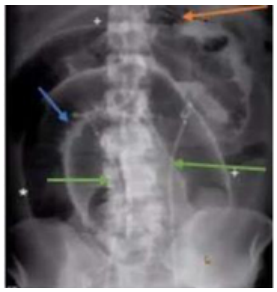
**Rx de tórax <u>normal</u>**

Aire libre en cúpulas diafragmáticas. Signo clave: doble pared (se ve la pared interna y externa del asa). Dx diferencial: diverticulitis, apendicitis o úlcera perforada.



**Neumoperitoneo**

Aire libre en cúpulas diafragmáticas. Signo clave: doble pared (se ve la pared interna y externa del asa). Dx diferencial: diverticulitis, apendicitis o úlcera perforada.



**Litiasis Renal y Biliar**

Aire libre en cúpulas diafragmáticas. Signo clave: doble pared (se ve la pared interna y externa del asa). Dx diferencial: diverticulitis, apendicitis o úlcera perforada.



**Patrón de Aire Intestinal y Obstrucción**

De pie: niveles hidroaéreos, delgado central y grueso periférico. Causas más frecuentes de obstrucción: adherencias, hernias y neoplasias. Regla 3/6/9 para dilatación patológica.



**Calcificaciones Aórticas**

Hallazgo frecuente en mayores de 70 años, sobre todo fumadores. Puede causar dolor abdominal inespecífico; no confundir con patología aguda.



**Intestino Delgado vs. Colon**

Válvulas conniventes cruzan todo el lumen del delgado (a diferencia de las haustras del colon). Los flebolitos pélvicos no deben confundirse con litos.




**Íleo**

Dilatación homogénea de las asas, sin punto de transición claro. Los niveles hidroaéreos apoyan el diagnóstico, pero su ausencia no lo descarta.



**Vólvulo: "Semilla de Café"**

Campos simétricos, tráquea central, bronquios definidos, burbuja gástrica, hígado y bazo en su posición habitual.



**RX en el Paciente Mayor**

Calcificación aórtica, degeneración articular, sombra hepática menos marcada, y a veces una masa pélvica que desplaza las asas hacia arriba.

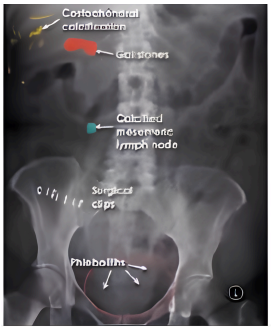


# IMAGENOLOGÍA EN CIRUGÍA

DRA. DEBBIE WONG

**Hallazgos Múltiples en Una Placa**

Una sola Rx puede mostrar colelitiasis, clips quirúrgicos, flebolitos, nódulo mesentérico calcificado y artefactos como piercings, catéter doble J o pesario.




**Psoas, Riñones y Simetría Ósea**

Deben verse ambos psoas, los dos riñones y el marco cólico completo sin distensión. En CA metastásico pueden verse lesiones osteolíticas asimétricas.

